SUH
SERVICIO DE URGENCIAS
Hospital de Antequera

SaludNorteMálaga
SaludNorteMalaga @saludnortemalag

Junta de Andalucía
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias



ACSA Unidad certificada · Nivel Óptimo

Memoria de Supervisión de Enfermería *2026*

Servicio de Urgencias · Hospital de Antequera
Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga · Servicio Andaluz de Salud

MI

Manuel Isaías Medina Pérez
Supervisor de Enfermería del Servicio de Urgencias Hospitalarias

DOCUMENTO PARA LA PRESENTACIÓN ANTE EL TRIBUNAL

CONTENIDO

Índice

01	Resumen ejecutivo	3
02	Carta del supervisor · Misión, visión y valores	4
03	La unidad y sus espacios	5
04	Triaje, circuitos, TECLA y TICLA	6
05	Gestión de personas y gobernanza	7
06	Gestión por procesos	8
07	Cuidados de enfermería y seguridad del paciente	9
08	Calidad: certificación ACSA nivel Óptimo	10
09	Mapa de estándares y evidencias ACSA	11
10	Análisis DAFO	13
11	Estrategias CAME e indicadores	15
12	Plan de acción 2027	16
13	Transformación digital: herramientas del servicio	17
14	El portal web del proyecto	19
15	Presentación ante el tribunal	20
16	Acceso al proyecto · Código QR	21

Ficha del documento

Título	Memoria de Supervisión de Enfermería 2026
Unidad	Servicio de Urgencias Hospitalarias · Hospital de Antequera
Área	Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga · Servicio Andaluz de Salud
Autor	Manuel Isaías Medina Pérez, Supervisor de Enfermería
Destinatario	Tribunal de evaluación de la memoria
Marco de calidad	Manual de Estándares de Unidades de Gestión Sanitaria ME 5 1_08 (ACSA) · Certificación nivel Óptimo
Fecha	Octubre de 2026

01 · RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto *en una página*

El Servicio de Urgencias del Hospital de Antequera combina una calidad acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía con un modelo de supervisión centrado en las personas, los procesos y la seguridad. Esta memoria resume el trabajo de 2026, el análisis estratégico y el plan para 2027, y se acompaña de un portal web con la presentación del proyecto y todas las herramientas del servicio.

Óptimo
Nivel de certificación ACSA

20
Herramientas digitales propias

12
Procesos con PNT digitalizado

9
Áreas asistenciales documentadas

Calidad acreditada
Certificación ACSA nivel Óptimo: 100 % del grupo I (incluidos los obligatorios) y más del 40 % del grupo II. Visita reciente de evaluadores con muy buena experiencia.

Gobernanza y clima laboral
Tras la auditoría de prevención de riesgos laborales, reuniones de gobernanza con el equipo para decidir medidas y mejorar el clima.

Auditorías de cuidados
Auditorías de dolor (ES 5 04.06_01) y del registro de continuidad de cuidados (ES 5 03.11_02 · 03.12_02).

Área de mejora: TECLA y TICLA
Reducir la espera hasta la clasificación (meta propuesta ≤ 10 min) y la duración del triaje (≤ 5 min).

Ecosistema digital propio
20 herramientas interactivas basadas en los PNT del área: triaje, códigos, críticos, cuidados y educación.

Humanización y ciudadanía
Paciente frágil con cuidador, atención en intimidad a víctimas de violencia, educación sanitaria y redes sociales.

Hilo conductor: «Cuidar a quien llega, cuidar a quien cuida». La calidad asistencial y el bienestar de los profesionales se refuerzan mutuamente.

02 · CARTA DEL SUPERVISOR

Cuidar a quien llega, *cuidar a quien cuida*

Esta memoria recoge el trabajo del equipo de enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital de Antequera durante 2026: un año marcado por la consolidación de la **certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en nivel Óptimo** y por una visita de evaluación vivida por el equipo como una experiencia muy positiva.

Nuestro reto diario es doble: atender con rapidez y seguridad a quien llega en el peor momento, y cuidar a los profesionales que hacen posible esa atención. Por eso, tras la auditoría de prevención de riesgos laborales, hemos convertido las **reuniones de gobernanza** en un espacio estable para escuchar, decidir juntos y mejorar el clima laboral.

Hemos medido lo que importa —el dolor de nuestros pacientes y la calidad del registro de continuidad de cuidados— y hemos digitalizado nuestros protocolos en herramientas que el equipo usa a pie de cama. También sabemos dónde tenemos que mejorar: reducir la **TECLA** (lo que espera el paciente hasta que lo clasifican) y la **TICLA** (lo que dura la clasificación) será nuestra prioridad para 2027.

Gracias a cada enfermera, enfermero, TCAE, celador, médico y personal de apoyo del servicio. Esta memoria es vuestra.

MI

Manuel Isaías Medina Pérez
Supervisor de Enfermería · Servicio de Urgencias · Hospital de Antequera

Misión, visión y valores

Misión

Prestar atención urgente de calidad, segura y humana a la población del Área Sanitaria Norte de Málaga, priorizando según la gravedad y garantizando la continuidad de cuidados al alta.

Visión

Ser un servicio de urgencias de referencia por su excelencia en cuidados, su cultura de seguridad, su innovación digital y el bienestar de sus profesionales.

Valores

- Seguridad
- Humanización
- Trabajo en equipo
- Evidencia
- Transparencia
- Innovación
- Respeto

03 · LA UNIDAD

Nueve áreas, *un mismo equipo*

El Servicio de Urgencias se organiza en áreas funcionales diferenciadas que permiten aplicar los circuitos del PNT de triaje. Las 72 fotografías del portal documentan el estado actual de las instalaciones; aquí se muestra una imagen representativa de cada área.



Entrada de Urgencias

Acceso peatonal y de transporte sanitario, con circuito diferenciado para ambulancias.



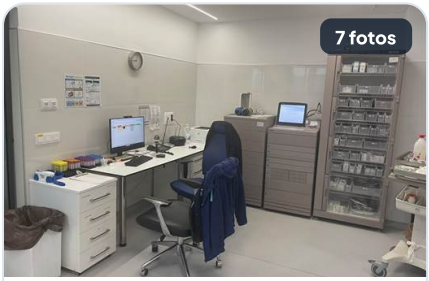
Triaje

Clasificación por enfermería con el Sistema Español de Triaje (SET) y web_e-PAT.



Sala de espera

Espera tras triaje con información visible y puesto de admisión.



Consultas de Enfermería

Puestos de técnicas, tratamientos y cuidados con material normalizado.



Consultas médicas

Consultas de policlínica y circuito polivalente.



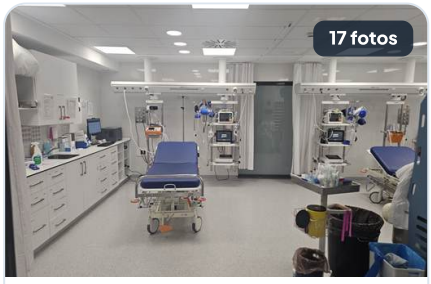
Sala de tratamiento

Observación leve en sillones y administración de tratamientos.



Pasillo de Críticos

Circulación interna protegida que conecta críticos y observación.



Sala de Críticos

Tres puestos de críticos con monitorización y dotación según el PNT-URG-CRIT-001.



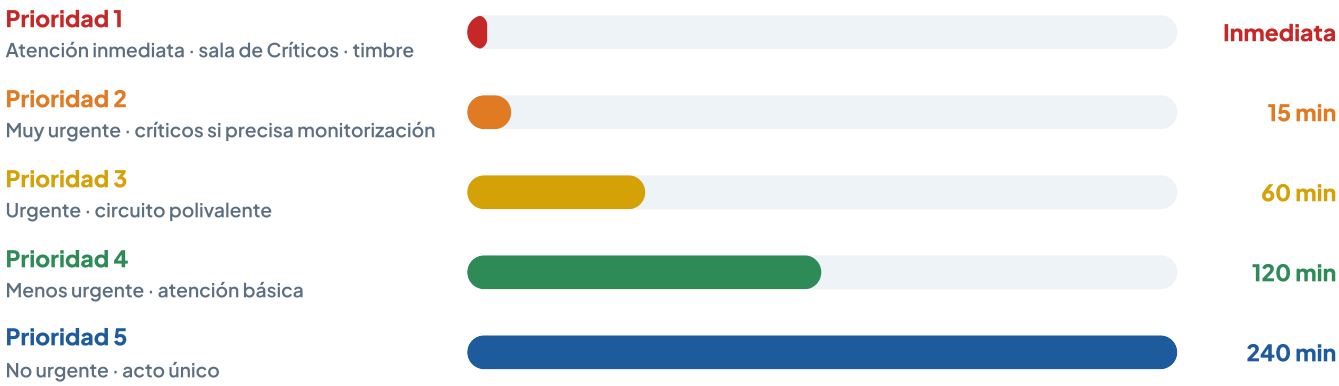
Observación grave

Camas monitorizadas con control de enfermería centralizado.

04 · TRIAJE Y CIRCUITOS

La gravedad *marca el orden*

Enfermería de triaje clasifica a cada paciente con el **Sistema Español de Triaje (SET)** de cinco niveles y el programa web_e-PAT, según el PNT de triaje (versión 6, junio de 2026). Las barras representan el tiempo máximo de atención de cada prioridad.



Seis circuitos asistenciales excluyentes

- Críticos
- Polivalente
- Atención básica
- Traumatológico
- Pediátrico (< 14 años)
- Obstétrico-ginecológico

Las patologías tiempo-dependientes —dolor torácico, ictus, trauma grave y sepsis— se tratan como prioridad 1 con su propio código.

Área de mejora prioritaria: TECLA y TICLA



El PNT ya prevé una segunda consulta de triaje en las horas de máxima afluencia para acortar ambos tiempos. Las metas son propuestas de la supervisión basadas en las referencias habituales del SET.

Fragilidad y violencia, detectadas en triaje

- ✓ **Paciente frágil:** EPADI de 6 o más, seguimiento por Cuidados Paliativos o tarjeta +Cuidado. Se anota «PF» y la puntuación, pegatina amarilla, cuidador acompañante y profesionales responsables asignados.
- ✓ **Dependencia en Diraya-Urgencias:** el nombre se sombrea en blanco, verde, amarillo o rojo según dependencia y acompañamiento.
- ✓ **Sospecha de violencia de género:** Protocolo Andaluz, atención a solas en la consulta 12, prioridad entre 1 y 3 y registro CMT / ISMT.

05 · GESTIÓN DE PERSONAS

Nadie empieza solo, *todos aprendemos*

Acogida y funciones

Cada incorporación recibe el **Plan de Acogida PG-UAP-01 (versión 6, octubre 2025)** del Área, junto con el documento de funciones y responsabilidades del Hospital de Antequera y el plano de evacuación de Urgencias, convertidos en una guía de estudio interactiva. ES 5 01.10_02 ES 5 06.08_03

Formación

La preparación de la acreditación se apoyó en **El Juego de la Acreditación**: 102 puntos del checklist de Calidad, los requisitos del Excel de 50 estándares y el Manual ME 5 1_08 en casos «¿cumple o no cumple?». Cada protocolo digital incluye tarjetas de repaso. ES 5 01.12_04

Fortaleza: de la auditoría de PRL al clima laboral

La auditoría de prevención de riesgos laborales identificó riesgos de seguridad, ergonómicos y psicosociales propios de un servicio de urgencias. La respuesta de la supervisión ha sido institucionalizar **reuniones de gobernanza** con los profesionales.

1 **Auditoría PRL**
Riesgos de seguridad, ergonómicos y psicosociales.
ES 5 06.06_02

›

2 **Reuniones de gobernanza**
El equipo analiza, prioriza y decide.
ES 5 01.01_01

›

3 **Medidas acordadas**
Prevención de agresiones, PNT de contención y organización del trabajo.

›

4 **Mejor clima laboral**
Medido y difundido como motor organizativo.
ES 5 01.16_02

Qué aportan las reuniones de gobernanza

- ✓ Analizar conjuntamente los hallazgos de la auditoría y priorizar medidas preventivas.
- ✓ Abordar la prevención de agresiones y el manejo del paciente agitado según el PNT de contención.
- ✓ Dar voz al equipo en la organización del trabajo, reforzando el modelo de gobierno clínico.
- ✓ Utilizar el clima laboral como palanca de desarrollo organizativo, con medición y difusión de resultados.



Diapositiva de la presentación del proyecto: de la auditoría de PRL al clima laboral.

06 · GESTIÓN POR PROCESOS

Protocolos vivos, *no en un cajón*

Los procesos asistenciales del servicio están documentados en Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) con código, versión y fecha, y se han trasladado a herramientas interactivas que facilitan su aplicación a pie de cama y su evaluación (ES 5 02.01_04, procesos asistenciales implantados).

PROCESO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ESTÁNDAR ACSA
Triaje y asignación	PNT de triaje · v6 · junio 2026	ES 5 02.01_04
Sala de Críticos	PNT-URG-CRIT-001 · v1.0 · 2026	ES 5 02.01_04
Código Ictus	Teleictus (CATI) · ventana terapéutica	ES 5 02.01_04
Código Sepsis	Actualización Sepsis · 04–may–2026	ES 5 05.06_01
Código Trauma	PNT 5.1 (anexos III-VI)	ES 5 02.01_04
Dolor torácico agudo	SCACEST v5 · mar 2025 / SCASEST · sep 2024	ES 5 04.01_03
Urgencias gineco-obstétricas	PNT Área Norte · v2 · sep 2026	ES 5 03.16_00
Dolor en Urgencias	PNT v1 · 15/12/2025	ES 5 04.06_01
Fluidoterapia	PNT v1.0 · 3 dic 2025	ES 5 05.10_00
Paciente agitado y contención	PNT 2024 · PG-CAL-11	ES 5 05.06_01
Manejo de heridas	Comisión de Heridas AGSNM 2025–2026	ES 5 04.01_03
Acogida de profesionales	PG-UAP-01 · v6 · oct 2025	ES 5 01.10_02

Códigos tiempo-dependientes

Ictus
Ventana terapéutica, fibrinólisis, trombectomía y Teleictus.

Sepsis
NEWS2 automático, foco y antibioterapia empírica.

Trauma
Criterios de activación, TSR, Glasgow y ventana del tranexámico.

Infarto
SCACEST v5 y SCASEST: criterios ECG y reperfusión.

La digitalización también es control de calidad: al trasladar el PNT de Críticos a formato interactivo se detectaron una fecha de aprobación anterior a la de elaboración, una dotación sin destino y varias erratas, que se han devuelto a la Unidad para su corrección (ES 5 01.05_00 · ES 5 05.01_03).

07 · CUIDADOS Y SEGURIDAD

Cuidados *que se miden*

Auditorías de dolor

ES 5 04.06_01 · obligatorio El abordaje del dolor es un estándar obligatorio. Las auditorías comprueban sus cuatro elementos evaluables:

- ✓ Escalas validadas (EVA, EVN…) registradas en la historia de salud.
- ✓ Aplicación del PNT de Dolor en Urgencias (v1, 15/12/2025) con medidas farmacológicas y no farmacológicas.
- ✓ Información verbal y escrita del tratamiento: nombre, dosis, posología, vía y duración.
- ✓ Formación de los profesionales en el manejo del dolor.

Registro de continuidad de cuidados

ES 5 03.11_02 ES 5 03.12_02 La auditoría del informe de continuidad de cuidados verifica:

- ✓ Asignación de enfermera y médico de referencia.
- ✓ Plan de cuidados NANDA-NIC-NOC adaptado al proceso.
- ✓ Transmisión de la información a Atención Primaria al alta.
- ✓ Calidad del registro y retorno de resultados al equipo.

Fragilidad, heridas y educación sanitaria

- ✓ **EPADI:** índice de fragilidad de 0 a 10 (edad, Pfeiffer, Barthel, Charlson, Gijón y pluripatología) que activa el circuito de paciente frágil a partir de 6.
- ✓ **Heridas:** evaluación y manejo local TIMERS con el catálogo de la Comisión de Heridas AGSNM 2025–2026.
- ✓ **Educación sanitaria:** hojas por motivo de consulta y portal de Recomendaciones de Salud con 21 guías al alta y 15 consejos de promoción, cada uno con sus fuentes (GPC, revisiones sistemáticas, OMS, Ministerio de Sanidad).

Seguridad del paciente

PRÁCTICA SEGURA	CÓMO SE APLICA	ESTÁNDAR
Identificación inequívoca	NHC / NUHSA en todos los registros y fichas de apoyo.	ES 5 05.05_03
Contención como último recurso	Desescalada verbal primero; sujeción con ≥ 4 personas, valoración facultativa < 1 h y revisión ≤ 4 h.	ES 5 05.06_01
Fluidoterapia segura	Herramienta de apoyo al PNT v1.0 de diciembre de 2025.	ES 5 05.10_00
Detección precoz de sepsis	NEWS2 calculado automáticamente en el Código Sepsis.	ES 5 05.06_01
Protección de datos	Las herramientas no guardan ni envían datos de pacientes.	ES 5 06.14_03

08 · CALIDAD ACREDITADA

Certificación ACSA: *nivel Óptimo*

ACSA ÓPTIMO

Unidad certificada en nivel Óptimo

Manual de Estándares de Unidades de Gestión Sanitaria ME 5 1_08 (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 2022). La reciente visita de los evaluadores fue una muy buena experiencia para todo el equipo y confirmó la madurez del sistema de calidad del servicio.

Estructura del manual

76 estándares agrupados en **3 bloques** y **6 criterios**. Los estándares son dicotómicos (se cumplen o no) y se clasifican en grupo I (con obligatorios), grupo II (mayor desarrollo organizativo) y grupo III (innovación y desarrollo para la sociedad). El certificado tiene una vigencia de 5 años con fase de seguimiento.

Bloque 1 · Gestión de la unidad

Criterio 1 · Liderazgo y organización
Criterio 2 · Gestión por procesos asistenciales

Bloque 2 · Atención centrada en el paciente

Criterio 3 · Derechos y continuidad asistencial
Criterio 4 · Calidad científico-técnica

Bloque 3 · Seguridad

Criterio 5 · Seguridad del paciente
Criterio 6 · Soporte

Niveles de certificación

	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Avanzado	> 70 %	—	—
Óptimo SUH	100 %	> 40 %	—
Excelente	100 %	100 %	> 40 %



Diapositiva de la presentación: certificación ACSA nivel Óptimo.

09 · MAPA DE EVIDENCIAS

Estándares clave *y evidencias del servicio*

Selección de estándares del Manual ME 5 1_08 especialmente relacionados con la supervisión de enfermería, con la evidencia que aporta el servicio. Los estándares obligatorios se señalan en rojo. **Criterios 1 a 3.**

CÓDIGO	GRUPO	ESTÁNDAR (RESUMEN)	EVIDENCIA DEL SERVICIO
ES 5 01.01_01 Criterio 1	I	**Modelo de gobierno clínico definido**	Reuniones de gobernanza periódicas, reforzadas tras la auditoría de prevención de riesgos laborales.
ES 5 01.05_00 Criterio 1	I	**Sistema de gestión documental**	PNT digitalizados con código, versión y fecha; control de versiones de las herramientas.
ES 5 01.07_00 Criterio 1	II	**Auditorías internas del plan de calidad**	Auditorías de dolor y del registro de continuidad de cuidados; Juego de la Acreditación como autoevaluación.
ES 5 01.08_02 Criterio 1	II	**Memoria anual de actividades**	Esta memoria de supervisión, publicada en el portal.
ES 5 01.10_02 Criterio 1	**I · obligatorio**	**Funciones y responsabilidades de cada puesto**	Documento «Funciones y responsabilidades» integrado en la herramienta de Acogida.
ES 5 01.12_04 Criterio 1	I	**Plan de formación según necesidades**	Acogida PG-UAP-01 v6, tarjetas de repaso en cada PNT y gamificación ACSA.
ES 5 01.16_02 Criterio 1	II	**Clima laboral como elemento de desarrollo organizativo**	Plan de mejora del clima laboral derivado de las reuniones de gobernanza post-auditoría PRL.
ES 5 02.01_04 Criterio 2	**I · obligatorio**	**Procesos asistenciales implantados**	Triaje SET, Sala de Críticos, Códigos Ictus, Sepsis, Trauma e Infarto, circuito gineco-obstétrico.
ES 5 02.02_03 Criterio 2	I	**Cumplimiento de indicadores de procesos**	Cuadro de indicadores de la memoria con metas propuestas.
ES 5 02.03_03 Criterio 2	II	**Evaluación de la adhesión a los procesos**	Fichas de registro de apoyo y revisión de sala de críticos.
ES 5 03.01_00 Criterio 3	I	**Humanización de la asistencia**	Circuito de paciente frágil (EPADI ≥ 6), acompañamiento del cuidador y colores de dependencia en Diraya.
ES 5 03.02_03 Criterio 3	**I · obligatorio**	**Intimidad y confidencialidad**	Consulta 12 para sospecha de violencia de género; herramientas que no almacenan datos de pacientes.
ES 5 03.08_02 Criterio 3	**I · obligatorio**	**Accesibilidad e información sobre la unidad**	Instagram @suh_antequera_ con destacados de Guía de usuario, Derechos, Deberes y Teléfonos.
ES 5 03.09_03 Criterio 3	I	**Tiempos de respuesta**	Tiempos máximos del SET (0–15–60–120–240 min); área de mejora en TECLA (espera hasta la clasificación) y TICLA (duración de la clasificación).
ES 5 03.11_02 Criterio 3	**I · obligatorio**	**Auditoría de la calidad de los registros de la historia de salud**	Auditoría del registro de continuidad de cuidados.
ES 5 03.12_02 Criterio 3	**I · obligatorio**	**Profesionales de referencia y plan de cuidados**	Enfermera y médico responsables asignados; informe de continuidad de cuidados al alta.

09 · MAPA DE EVIDENCIAS (CONTINUACIÓN)

Calidad científico-técnica *y seguridad*

Criterios 4 a 6. Calidad científico-técnica, seguridad del paciente y soporte.

CÓDIGO	GRUPO	ESTÁNDAR (RESUMEN)	EVIDENCIA DEL SERVICIO
ES 5 04.01_03 Criterio 4	I	**Prácticas basadas en la evidencia**	Recomendaciones al alta con fuentes (GPC, revisiones sistemáticas, organismos oficiales).
ES 5 04.04_00 Criterio 4	II	**Prevención primaria y secundaria**	15 consejos de promoción de la salud: RCP, ictus, tabaco, actividad física…
ES 5 04.05_00 Criterio 4	I	**Prevención terciaria**	Hojas de educación sanitaria por proceso y signos de alarma.
ES 5 04.06_01 Criterio 4	**I · obligatorio**	**Abordaje específico del dolor**	PNT Dolor v1, escalas validadas, información escrita del tratamiento y auditorías de dolor.
ES 5 05.01_03 Criterio 5	**I · obligatorio**	**Gestión de riesgos**	Revisión de sala de críticos y detección de incoherencias documentales.
ES 5 05.02_03 Criterio 5	**I · obligatorio**	**Notificación de incidentes**	Cultura de notificación en las reuniones de gobernanza.
ES 5 05.05_03 Criterio 5	**I · obligatorio**	**Identificación inequívoca de pacientes**	Uso de NHC / NUHSA en todas las fichas de apoyo.
ES 5 05.06_01 Criterio 5	**I · obligatorio**	**Prácticas seguras**	Contención mecánica como último recurso, Código Sepsis, prevención de errores.
ES 5 05.10_00 Criterio 5	**I · obligatorio**	**Preparación y administración de medicamentos**	Herramienta de Fluidoterapia según PNT v1.0.
ES 5 06.06_02 Criterio 6	**I · obligatorio**	**Riesgos laborales, incluidos los psicosociales**	Auditoría de prevención de riesgos laborales y plan de acción en gobernanza.
ES 5 06.08_03 Criterio 6	**I · obligatorio**	**Actuación ante emergencias**	Plano de evacuación de Urgencias incluido en la Acogida.
ES 5 06.13_02 Criterio 6	I	**Caída de sistemas de información**	Herramientas locales que funcionan sin servidor como respaldo de consulta.
ES 5 06.14_03 Criterio 6	**I · obligatorio**	**Protección de datos**	Las herramientas no guardan ni envían datos de pacientes.

Hacia el nivel Excelente: requiere el 100 % de los grupos I y II y más del 40 % del grupo III. Estándares del grupo III a abordar: comparación de resultados con otras unidades (ES 5 01.09_03), satisfacción de clientes internos (ES 5 01.17_00), experiencia del paciente en la mejora de procesos (ES 5 02.05_00) e investigación financiada (ES 5 04.08_02).

10 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Análisis DAFO · *interno*

Fortalezas y debilidades del servicio. Como fortalezas destacan las reuniones de gobernanza tras la auditoría de prevención de riesgos laborales, y las auditorías de dolor y del registro de continuidad de cuidados; como área de mejora prioritaria, la TECLA y la TICLA.

Fortalezas

- **Certificación ACSA nivel Óptimo**
  Cumplimiento del 100 % de los estándares del grupo I (incluidos los obligatorios) y más del 40 % del grupo II del Manual ME 5 1_08. Reciente visita de evaluación con muy buena experiencia del equipo evaluador.
- **Reuniones de gobernanza tras la auditoría de PRL**
  Tras la auditoría de prevención de riesgos laborales, la supervisión impulsa reuniones de gobernanza con los profesionales para analizar riesgos, incluidos los psicosociales, y acordar medidas que mejoran el clima laboral.
- **Auditorías de dolor**
  Evaluación periódica del registro del dolor con escalas validadas, aplicación del PNT de Dolor (v1, 15/12/2025), información escrita del tratamiento y formación del equipo.
- **Auditoría del registro de continuidad de cuidados**
  Revisión de la cumplimentación del informe de continuidad de cuidados al alta y de la asignación de profesionales de referencia.
- **Ecosistema digital propio**
  20 herramientas interactivas construidas a partir de los PNT del área: triaje, códigos tiempo-dependientes, críticos, cuidados y educación sanitaria.
- **Triaje estructurado y circuitos definidos**
  SET de 5 niveles con web_e-PAT, seis circuitos asistenciales, detección de fragilidad (EPADI ≥ 6) y de violencia de género.
- **Plan de acogida y funciones definidas**
  Plan PG-UAP-01 v6 (octubre 2025), funciones y responsabilidades por puesto y plano de evacuación.
- **Instalaciones renovadas**
  Sala de Críticos con tres puestos, observación grave monitorizada y circulación interna protegida.

Debilidades

- **Tiempo de TECLA y TICLA** PRIORIDAD
  Área de mejora prioritaria. TECLA es el tiempo de espera hasta la clasificación: lo que espera el paciente desde su llegada hasta que lo clasifican. TICLA es el tiempo de clasificación: lo que dura el triaje. Ambos retrasan la asignación de prioridad y, con ella, la atención de los pacientes más graves. El PNT ya prevé una segunda consulta de triaje en horas de máxima afluencia para acortarlos.
- **Cumplimiento variable de tiempos en P3–P5**
  El PNT de triaje reconoce que las prioridades 3, 4 y 5 se cumplen en un porcentaje muy alto, pero no siempre, por la demanda asistencial.
- **Coherencia documental**
  Al digitalizar el PNT de Críticos se detectaron una fecha de aprobación anterior a la de elaboración, una dotación sin destino y erratas, pendientes de aclarar.
- **Herramientas sin integración con Diraya**
  Las herramientas digitales no se integran con la historia clínica: los datos no se guardan y el registro oficial sigue haciéndose en Diraya Urgencias.
- **Varias versiones de un mismo recurso**
  Coexisten versiones de Educación para la Salud (v1–v3) y de Recomendaciones al Alta; se necesita un circuito de validación y retirada de versiones.

10 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO (CONTINUACIÓN)

Análisis DAFO · *externo*

Oportunidades y amenazas del entorno sanitario del Área Norte de Málaga.

Oportunidades

- **Camino hacia el nivel Excelente**
  El certificado tiene 5 años de vigencia con seguimiento. Avanzar en el grupo III: comparación con otras unidades (ES 5 01.09_03), satisfacción de clientes internos (ES 5 01.17_00), experiencia del paciente (ES 5 02.05_00) e investigación financiada (ES 5 04.08_02).
- **Plan de Humanización del SSPA**
  Marco para reforzar el acompañamiento, la intimidad y la atención al paciente frágil y a su cuidador.
- **Salud digital ciudadana**
  App Salud Andalucía y ClicSalud+ permiten reforzar la información al alta y la continuidad.
- **Coordinación con Atención Primaria**
  Continuidad de cuidados con las UGC del área (Antequera-Centro, Antequera-Estación, Archidona, Campillos, Mollina) y la Unidad de Residencias.
- **Formación innovadora**
  Gamificación, tarjetas de repaso y simulación como palancas de aprendizaje del equipo.
- **Redes sociales del servicio**
  Instagram @suh_antequera_ para promoción de la salud, información a la ciudadanía y visibilidad del equipo.

Amenazas

- **Presión asistencial y picos estacionales**
  Epidemias respiratorias invernales y olas de calor aumentan la demanda y tensionan los tiempos de respuesta.
- **Riesgos psicosociales y agresiones**
  El entorno de urgencias concentra situaciones de agitación y conflicto que afectan a la seguridad y al bienestar de los profesionales.
- **Rotación de profesionales**
  Las incorporaciones frecuentes exigen una acogida eficaz para mantener la calidad y la seguridad.
- **Caída de sistemas de información**
  La dependencia de Diraya y web_e-PAT requiere procedimientos alternativos definidos.
- **Envejecimiento y fragilidad**
  Aumenta la proporción de pacientes mayores, pluripatológicos y frágiles, con estancias más largas y mayor necesidad de cuidados.



Síntesis del DAFO en la presentación del proyecto.

11 · ESTRATEGIAS E INDICADORES

De la estrategia *a la medida*

Estrategias CAME

MANTENER · F

Consolidar la certificación Óptima

Seguimiento anual de estándares, autoevaluación con el Juego de la Acreditación y auditorías internas.

EXPLOTAR · F+O

De Óptimo a Excelente

Usar el ecosistema digital y las auditorías como base de proyectos de investigación, benchmarking y experiencia del paciente.

AFRONTAR · F+A

Gobernanza frente a riesgos psicosociales

Las reuniones de gobernanza post-PRL como espacio estable para prevenir agresiones y proteger el clima laboral.

CORREGIR · D+O

Reducir TECLA y TICLA

Medición basal desde web_e-PAT, segunda consulta de triaje activada por demanda, formación en SET y auditoría trimestral de los tiempos de triaje.

Cuadro de indicadores

Indicadores de seguimiento del proyecto. Las metas son propuestas de la supervisión; los resultados se registran en el portal a partir de las fuentes indicadas.

INDICADOR	FÓRMULA	META	FUENTE	ESTÁNDAR
Pacientes con dolor valorado con escala validada	Pacientes con registro de escala / pacientes auditados × 100	**≥ 90 %**	Auditoría de historias	ES 5 04.06_01
Altas con informe de continuidad de cuidados (cuando procede)	Informes cumplimentados / altas que lo requieren × 100	**≥ 85 %**	Auditoría de registros	ES 5 03.12_02
TECLA · tiempo de espera hasta la clasificación	Minutos desde la llegada (admisión) hasta el inicio del triaje (mediana)	**≤ 10 min**	web_e-PAT	ES 5 03.09_03
TICLA · tiempo de clasificación	Minutos de duración del triaje, del inicio al fin (mediana)	**≤ 5 min**	web_e-PAT	ES 5 03.09_03
Pacientes P1 atendidos de forma inmediata	P1 con atención inmediata / total P1 × 100	**100 %**	web_e-PAT / Diraya	ES 5 03.09_03
Pacientes P2 atendidos en ≤ 15 min	P2 atendidos en tiempo / total P2 × 100	**100 %**	web_e-PAT / Diraya	ES 5 03.09_03
Reuniones de gobernanza realizadas	Reuniones con acta / reuniones programadas	**12 / año**	Actas de gobernanza	ES 5 01.01_01
Profesionales de nueva incorporación con acogida	Acogidas completadas / incorporaciones × 100	**100 %**	Registro de acogida	ES 5 01.12_04
Notificaciones de seguridad del paciente	Número de notificaciones analizadas	**Tendencia creciente**	Sistema de notificación	ES 5 05.02_03
Participación en la encuesta de clima laboral	Respuestas / profesionales × 100	**≥ 60 %**	Encuesta de clima	ES 5 01.16_02

12 · PLAN DE ACCIÓN 2027

Seis compromisos *para 2027*

El plan traduce el DAFO en acciones concretas, con responsable en la supervisión, seguimiento en las reuniones de gobernanza y vinculación a los estándares ACSA.

1 Reducir TECLA y TICLA en triaje

→ Medir TECLA y TICLA basales por franja horaria desde web_e-PAT
→ Activar la segunda consulta de triaje según la demanda
→ Formación y entrenamiento del equipo de triaje en el SET
→ Auditoría trimestral de tiempos y retorno al equipo

ES 5 03.09_03

2 Consolidar la gobernanza y el clima laboral

→ Reunión de gobernanza mensual con acta y seguimiento
→ Plan de acción derivado de la auditoría PRL
→ Medición del clima laboral bienal
→ Difusión de resultados al equipo

ES 5 01.16_02 · ES 5 06.06_02

3 Auditorías de dolor y continuidad de cuidados

→ Auditoría trimestral de registro del dolor
→ Auditoría del informe de continuidad de cuidados
→ Retroalimentación individual y grupal
→ Sesiones formativas en manejo del dolor

ES 5 04.06_01 · ES 5 03.12_02

4 Gobierno de las herramientas digitales

→ Responsable y fecha de revisión por herramienta
→ Validación clínica antes de uso asistencial
→ Retirada de versiones anteriores
→ Corrección de incoherencias documentales detectadas

ES 5 01.05_00

5 Humanización y educación sanitaria

→ Hoja de recomendaciones al alta con evidencia
→ Circuito de paciente frágil y cuidador
→ Calendario de publicaciones en Instagram
→ Encuesta de experiencia del paciente

ES 5 03.01_00 · ES 5 02.05_00

6 Hacia la certificación Excelente

→ Mapa de estándares del grupo III
→ Comparación de resultados con otras unidades
→ Satisfacción de clientes internos (AP, servicios)
→ Comunicación científica de las innovaciones

Grupo III



Diapositiva de la presentación: TECLA y TICLA, área de mejora prioritaria.

13 · TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Ecosistema digital *del servicio*

El servicio dispone de 20 herramientas interactivas propias que funcionan en cualquier navegador, sin instalación ni servidor y sin guardar datos de pacientes. Todas comparten una barra de acceso al portal y a las redes sociales del servicio.

HERRAMIENTA	ÁREA	VERSIÓN / REFERENCIA	CONTENIDO
Recomendaciones de Salud y al Alta	Educación sanitaria	v2 · octubre 2026	21 guías de cuidados al alta y 15 consejos de promoción de la salud con fuentes de evidencia; hoja A4 para el paciente y registro NANDA-NIC-NOC para Diraya.
Educación para la Salud	Educación sanitaria	v3	Generador de hojas de educación sanitaria por motivo de consulta, con origen del contenido (unidad / complemento / borrador), validación y versiones.
Acogida a nuevos profesionales	Personas y calidad	PG-UAP-01 · v6 · oct 2025	Guía de estudio del Manual de Acogida del Área, funciones y responsabilidades del Hospital de Antequera y plano de evacuación de Urgencias.
El Juego de la Acreditación	Personas y calidad	ACSA ME 5 1_08	Gamificación para preparar la visita: 102 puntos del checklist de Calidad, requisitos del Excel de 50 estándares y Manual ME 5 1_08, con casos «¿cumple o no cumple?» y ranking.
Triaje y asignación de pacientes	Triaje y circuitos	PNT de triaje · v6 · jun 2026	SET de 5 niveles con web_e-PAT, recorrido del paciente, circuitos asistenciales, códigos, fragilidad (EPADI), violencia de género y criterios de observación.
Código Ictus	Códigos tiempo-dependientes	Teleictus (CATI)	Panel de guardia con cálculo de la ventana terapéutica, fibrinólisis IV y trombectomía, escalas y contraindicaciones.
Código Sepsis	Códigos tiempo-dependientes	Actualización 04-may-2026	Basado en «Actualización Sepsis. Código Sepsis» (Dra. M. Rizo Hoyos). NEWS2 automático, foco, antibioterapia empírica y repaso.
Código Trauma	Códigos tiempo-dependientes	PNT 5.1	Ficha del caso con criterios de activación, TSR, Glasgow, prioridad, ventana del ácido tranexámico y siguiente acción (XABCDE).
Dolor torácico agudo	Códigos tiempo-dependientes	SCACEST v5 · mar 2025 · SCASEST sep 2024	Criterios ECG, reperfusión y antitrombóticos según los PNT del área; cálculos automáticos y exportación.
Sala de Críticos	Protocolos clínicos (PNT)	PNT-URG-CRIT-001 · v1.0	Seis fases de actuación, puestos y dotación mínima, evaluación ABCDE, ficha de paciente, revisión de sala y tarjetas de repaso.

13 · TRANSFORMACIÓN DIGITAL (CONTINUACIÓN)

Protocolos, cuidados *y archivo*

HERRAMIENTA	ÁREA	VERSIÓN / REFERENCIA	CONTENIDO
Circuito gineco-obstétrico	Protocolos clínicos (PNT)	PNT v2 · sep 2026	Qué hacer según el motivo de consulta, ficha con destino según protocolo y estudio guiado.
Fluidoterapia en Urgencias	Protocolos clínicos (PNT)	PNT v1.0 · 3 dic 2025	Herramienta de apoyo al PNT «Uso de la fluidoterapia en Urgencias» (autora: Carmen Gómez Pérez).
Paciente agitado y contención	Protocolos clínicos (PNT)	PNT 2024 · PG-CAL-11	Escalera de actuación de la desescalada verbal a la sujeción mecánica como último recurso; tiempos de revisión y registro.
Dolor en Urgencias	Cuidados de enfermería	PNT v1 · 15/12/2025	Valoración del dolor, fármacos con dosis y precauciones, opioides, dolor oncológico y medidas no farmacológicas.
Manejo de Heridas	Cuidados de enfermería	Comisión de Heridas AGSNM 2025–2026	Evaluación de la herida, manejo local TIMERS, catálogo del área, informe de cura y formación.
Calculadora EPADI	Cuidados de enfermería	Fragilidad 0–10	Índice de fragilidad con edad, Pfeiffer, Barthel, Charlson, Gijón y pluripatología. EPADI ≥ 6 activa el circuito de paciente frágil.
Codificación CIE-9	Triaje y circuitos	196 diagnósticos	Buscador bidireccional diagnóstico ↔ código por aparatos, con favoritos y modos de estudio.
Educación para la Salud (v2)	Versiones anteriores	versión anterior	Versión previa del generador de hojas de educación sanitaria.
Educación para la Salud (v1)	Versiones anteriores	versión inicial	Primera versión del generador de hojas de educación sanitaria.
Recomendaciones al Alta (v1)	Versiones anteriores	versión inicial	Versión inicial del portal de recomendaciones al alta, sustituida por la v2 con evidencia.

Gobierno de las herramientas (2027): responsable y fecha de revisión por herramienta, validación clínica antes del uso asistencial, retirada de versiones anteriores y corrección de las incoherencias documentales detectadas (ES 5 01.05_00).

14 · EL PORTAL WEB

Toda la memoria, *en una web*

El proyecto se acompaña de un portal web que reúne la memoria, la presentación, el análisis estratégico, la acreditación, las herramientas y las imágenes del servicio, con la identidad visual del SUH y enlaces a sus redes sociales.



Portada del portal web del proyecto.

Secciones del portal

Inicio
Portada con cifras clave, sello ACSA y acceso a la presentación.

Memoria
Los 14 capítulos de esta memoria, imprimibles, con indicadores editables.

ACSA
Niveles de certificación y mapa interactivo de estándares y evidencias.

DAFO
DAFO interactivo y editable con detalle, estándar y herramienta.

Herramientas
Las 20 webs con buscador, filtros y vista previa.

Instalaciones
Galería de 72 fotografías de 9 áreas, ampliables.

Redes
Instagram @suh_antequera_, Facebook y X del área sanitaria.

Presentación
22 diapositivas, 15 minutos, notas del ponente y demos en directo.



Presentación · El servicio en imágenes.



Presentación · Análisis DAFO.

15 · EXPOSICIÓN ANTE EL TRIBUNAL

Guion de la presentación · *15 minutos*

#	DIAPOSITIVA	FIN
1	Portada	0:30
2	Agenda	0:55
3	El servicio en imágenes	1:35
4	Misión, visión y valores	2:10
5	Triaje SET y circuitos	2:55
6	Sala de Críticos	3:30
7	Modelo de supervisión en seis pilares	4:10
8	Acogida y formación	4:50
9	De la auditoría de PRL al clima laboral	5:40
10	Gestión por procesos	6:30
11	Códigos tiempo-dependientes	7:10
12	Demo en directo: Triaje	8:00
13	Seguridad del paciente	8:35
14	Auditorías de dolor + demo en directo	9:25
15	Continuidad de cuidados	10:10
16	Fragilidad, heridas y contención	10:45
17	Demo en directo: Recomendaciones de Salud	11:25
18	ACSA nivel Óptimo	12:15
19	Análisis DAFO	13:10
20	TECLA y TICLA	13:55
21	Plan 2027	14:40
22	Gracias	15:00



Portada de la presentación.

Cómo se presenta

- ✓ Se abre desde el portal o con el archivo **presentacion.html**.
- ✓ **F** pantalla completa · → avanzar · **N** notas del ponente.
- ✓ **A** modo automático: avanza solo según el tiempo previsto (15:00).
- ✓ Cronómetro con aviso si la exposición va con retraso.
- ✓ Tres demostraciones en directo de las herramientas del servicio.

Mensaje final para el tribunal: calidad acreditada, un equipo cuidado y escuchado, cuidados medidos y un plan claro para reducir la TECLA y la TICLA en 2027.

Escanea y accede *al proyecto*

El portal web reúne la memoria completa, la presentación de 15 minutos, el DAFO interactivo, el mapa ACSA, las 20 herramientas y las fotografías del servicio.

Portal web del proyecto

`medinavergaramaria03-blip.github.io/portal-suh-antequera/`

Instagram

@suh_antequera_

Facebook

SUH Antequera

Manuel Isaías Medina Pérez

Supervisor de Enfermería · Servicio de Urgencias · Hospital de Antequera

Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga · Octubre 2026